PREFEITURA DE ITAPEMA

Secretaria de Saúde

Departamento de Vigilância Epidemiológica



PLANO DE CONTINGÊNCIA

PARA O ENFRENTAMENTO DA DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA NO MUNICÍPIO DE ITAPEMA

2025/2026

SUS

PREFEITURA DE Itapema SECRETARIA DE SAÚDE

ITAPEMA CONTRA DENGUE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO DA DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA NO MUNICÍPIO DE ITAPEMA

ELABORAÇÃO: BRUNA LETICIA BRESSANINI
CIBELE D'AVILA K. CAVALCANTI
PÂMELA GOMES DE PAULO
REVISADO POR: FABRÍCIO LAZZARI
FABIANA DE OLIVEIRA
MÔNICA DOS SANTOS MENDES

ITAPEMA, 2025/2026

SUMÁRIO

1.INTRODUÇÃO..... 1
2. OBJETIVOS..... 4
2.1 OJETIVO GERAL..... 4
2.2 OBJETIVO ESPECÍFICO..... 4
3.JUSTIFICATIVA..... 5
4. FASE PREPARATÓRIA..... 6
5.NÍVEIS DE ALERTA DO PLANO DE CONTINGÊNCIA..... 12
5.1 AÇÕES A SEREM EXECUTADAS NO NÍVEL 1..... 15
5.1.1 Gestão..... 16
5.1.2 Vigilância Epidemiológica..... 17
5.1.3 Controle Vetorial..... 18
5.1.4 Assistência ao Paciente..... 19
5.1.5 Comunicação, Mobilização e Publicidade..... 21
5.2 AÇÕES A SEREM EXECUTADAS NO NÍVEL 2..... 22
5.2.1 Gestão..... 23
5.2.2 Vigilância Epidemiológica..... 23
5.2.3 Controle Vetorial..... 24
5.2.4 Assistência ao Paciente..... 24
5.2.5 Comunicação, Mobilização e Publicidade..... 24
5.3 AÇÕES A SEREM EXECUTADAS NO NÍVEL 3..... 25
5.3.1 Gestão..... 25
5.3.2 Vigilância Epidemiológica..... 25
5.3.3 Controle Vetorial..... 26
5.3.4 Assistência ao Paciente..... 26
5.3.5 Comunicação, Mobilização e Publicidade..... 26
6. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES..... 27
7. RESPONSÁVEIS..... 28
8. REFERÊNCIAS..... 29

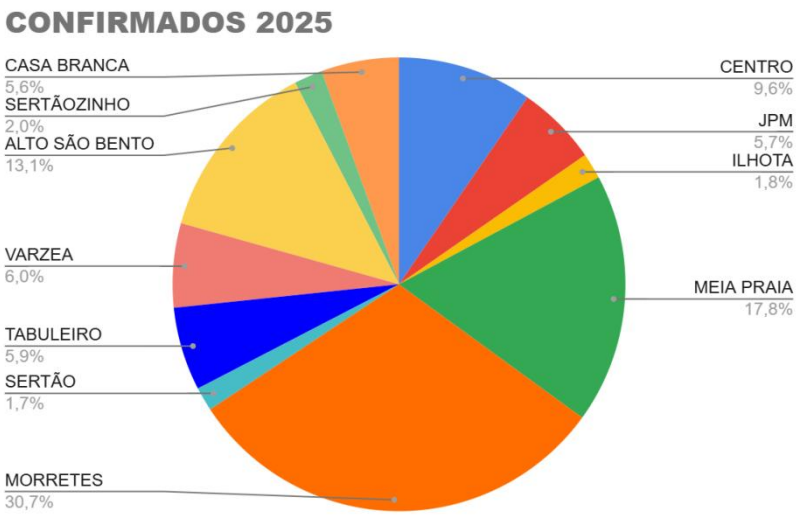
1.INTRODUÇÃO

A dengue, a chikungunya e a zika são arboviroses urbanas que apresentam sintomatologia clínica bastante semelhante, além de compartilharem o mesmo vetor: a fêmea do mosquito *Aedes aegypti* (BRASIL, 2025).

Estudos indicam que o *Aedes aegypti* foi introduzido no Brasil durante o período das grandes navegações. A primeira epidemia de dengue registrada no país ocorreu no município de Boa Vista, estado de Roraima, no ano de 1981 (BRASIL, 2025).

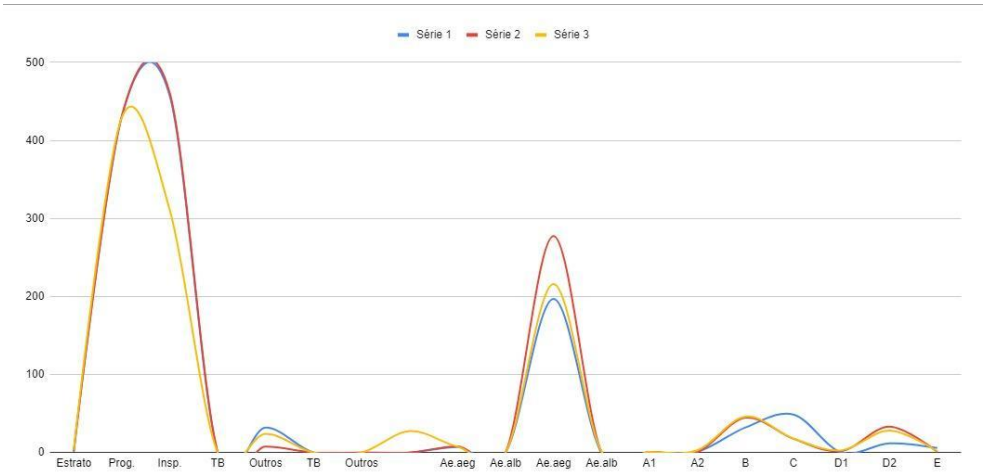
As arboviroses, especialmente a dengue, estão associadas a diversos fatores, como o crescimento populacional desordenado, a precariedade no saneamento básico e as condições climáticas favoráveis ao desenvolvimento do vetor. Esses fatores conferem à transmissão da doença um caráter sazonal, com aumento do risco de epidemias, principalmente entre os meses de outubro e maio (BRASIL, 2025).

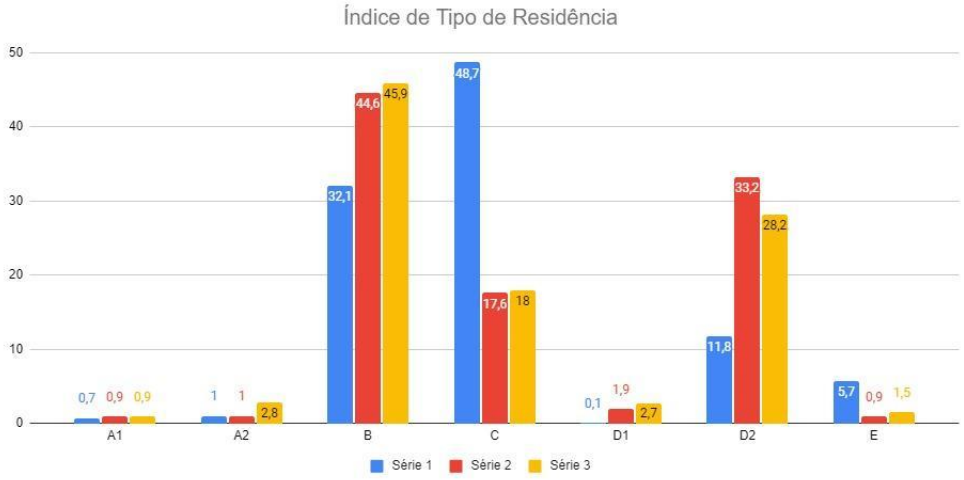
No ano de 2025, até o mês de setembro, o município registrou 4.270 notificações de casos de dengue, dos quais 1.624 foram confirmados laboratorialmente. Destes, oito casos foram considerados importados, sendo a maioria dos registros autóctones. O sorotipo predominante identificado foi o DENV-2. Os bairros com maior número de focos do vetor e de casos confirmados foram Morretes e Meia Praia (conforme gráfico abaixo).



O município de Itapema tem apresentado uma curva ascendente em seu crescimento populacional, contabilizando 75.940 habitantes, conforme dados do Censo Demográfico do IBGE de 2022. O território municipal está dividido em 11 bairros. No entanto, durante o período do verão, observa-se um aumento expressivo na circulação de pessoas, em razão do fluxo turístico característico da região.

Atualmente, onze desses bairros já são considerados áreas infestadas pelo mosquito *Aedes aegypti*. Os últimos Levantamentos de Índice Rápido do *Aedes aegypti* (LIRAa) demonstram que o Índice de Infestação Predial (IIP) tem apresentado tendência de crescimento nos últimos anos. Em 2022, o IIP era de 2,2%; nos anos de 2023 e 2024 manteve-se em 4,7%; e, em 2025, atingiu 7,6%, colocando o município em estado de alerta para a possibilidade de surto de arboviroses.





Diante desse cenário epidemiológico, tornou-se necessária a atualização do Plano de Contingência, com a definição de ações estratégicas de vigilância e controle voltadas ao enfrentamento da dengue, chikungunya e zika no município. O plano estabelece as responsabilidades dos diversos setores envolvidos frente a esses agravos, abrangendo desde situações de surtos até cenários epidêmicos que excedem as ações rotineiras de controle.

Por fim, o Plano de Contingência busca estabelecer os protocolos mais adequados para o enfrentamento de situações emergenciais relacionadas às arboviroses, promovendo a organização e articulação intersetorial necessárias. Com a integração dos esforços, será possível garantir uma resposta eficaz diante de eventuais epidemias de dengue, chikungunya e zika.

2. OBJETIVOS

2.1 OJETIVO GERAL

Prevenir a ocorrência de óbitos decorrentes de dengue, chikungunya e zika no município de Itapema.

2.2 OBJETIVO ESPECÍFICO

- Organizar a resposta da Secretaria Municipal de Saúde de Itapema diante do cenário de risco para arboviroses;
- Estabelecer fluxos e protocolos para garantir atendimento ágil e oportuno aos pacientes sintomáticos, especialmente durante períodos de aumento do número de casos;
- Fortalecer as ações de controle vetorial no município, com ênfase no bloqueio da transmissão do vírus;
- Estruturar a rede de atendimento nos diferentes níveis de atenção, conforme os protocolos e orientações do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde, considerando a classificação de risco e o manejo clínico adequado;
- Promover campanhas educativas e de mobilização social para conscientização da população sobre prevenção, eliminação de criadouros e busca precoce por atendimento;
- Implementar sistemas de vigilância epidemiológica e entomológica eficientes para monitorar a circulação dos vírus e a densidade do vetor (mapas de calor);
- Capacitar continuamente os profissionais de saúde para o diagnóstico precoce, manejo clínico e notificação adequada dos casos;
- Garantir a disponibilidade de insumos, medicamentos e recursos necessários para o manejo clínico e controle vetorial durante surtos e epidemias;
- Estabelecer parcerias intersetoriais, envolvendo órgãos municipais, estaduais e a comunidade, para ações integradas de prevenção e controle das arboviroses;
- Avaliar periodicamente a efetividade das ações implementadas, com base em indicadores epidemiológicos e de controle vetorial, ajustando estratégias conforme necessário.

3.JUSTIFICATIVA

O município de Itapema é vulnerável à infestação pelo mosquito *Aedes aegypti*, devido à sua localização litorânea, ao intenso fluxo turístico e à presença da rodovia BR-101, fatores que favorecem a criação de condições ambientais propícias para surtos de dengue.

Nesse contexto, o principal objetivo do Plano de Contingência é prevenir óbitos decorrentes da dengue, além de implementar ações de prevenção que antecipem os riscos, possibilitando uma atuação proativa e a resposta rápida diante de eventuais transmissões. O plano delineia estratégias e atividades a serem executadas de forma oportuna, visando conter a disseminação do vírus e oferecer suporte adequado aos casos confirmados.

Este documento tem como finalidade fornecer diretrizes claras a todas as unidades e departamentos envolvidos, assegurando a revisão contínua e atualização das medidas adotadas pelos responsáveis, desde a elaboração das estratégias até a intervenção em situações emergenciais, considerando o cenário entomoepidemiológico vigente.

Diante desse panorama, é imperativo priorizar a elaboração e implementação de um plano abrangente, que contemple tanto a erradicação do vetor quanto a garantia de atendimento ágil e de qualidade aos pacientes afetados.

Considerando o aumento significativo no número de casos positivos de arboviroses em Itapema, torna-se imprescindível utilizar este Plano de Contingência como instrumento fundamental para o enfrentamento das epidemias de dengue, chikungunya e zika, incluindo a antecipação de possíveis agravamentos no quadro epidemiológico.

4. FASE PREPARATÓRIA

A fase preparatória de um Plano de Contingência é fundamental para garantir uma resposta eficiente, articulada e proporcional frente a eventos adversos que possam comprometer a saúde pública no município. Nesta etapa, destaca-se a importância da coleta, organização e análise de dados epidemiológicos dos anos anteriores, que permitirão compreender o comportamento sazonal das doenças, os principais agravos registrados, os públicos mais vulneráveis, bem como a capacidade de resposta dos serviços de saúde locais.

No contexto de Itapema, é imprescindível que o planejamento das ações seja realizado com base em evidências, respeitando as especificidades territoriais, populacionais e epidemiológicas do município. A análise retrospectiva de dados permitirá:

- Identificar os períodos de maior incidência de casos e agravos (ex: arboviroses, síndromes respiratórias, etc.);
- Avaliar a efetividade das ações adotadas em anos anteriores;
- Levantar os recursos humanos, materiais e estruturais disponíveis e necessários;
- Fortalecer a articulação intersetorial e a definição de fluxos e responsabilidades;
- Prever cenários e definir níveis de resposta graduados conforme a gravidade da situação.

Assim, a construção do Plano de Contingência não deve ser feita de forma reativa, mas sim proativa e estratégica, visando preservar a saúde da população, minimizar riscos e garantir a continuidade e qualidade da assistência nos diferentes pontos da rede.

Recomenda-se, portanto, que todas as áreas envolvidas participem ativamente da fase preparatória, subsidiando o plano com informações técnicas, operacionais e logísticas que favoreçam um planejamento realista, eficaz e compatível com a realidade do município de Itapema.

GESTÃO

- Prever atas de registro de preços para aquisição e manutenção de estoques de insumos estratégicos nas unidades, testes rápidos e materiais informativos, garantindo agilidade na resposta diante de cenários críticos;
- Prever atas para aquisição de equipamentos essenciais nas unidades hospitalares e de atenção básica, como kits para hidratação oral e venosa, poltronas, suportes de soro, bebedouros e copos descartáveis, visando o adequado acolhimento e manejo clínico dos pacientes;
- Planejar previamente a aquisição de medicamentos estratégicos, pactuando a compra nos períodos que antecedem as epidemias, conforme as necessidades epidemiológicas locais;
- Utilizar informações estratégicas e ferramentas preditivas, como painéis e bancos de dados, para emissão de alertas, mobilização rápida das equipes de saúde e orientação técnica quanto à prevenção e manejo clínico dos casos suspeitos ou confirmados;
- Divulgar semanalmente boletins epidemiológicos atualizados com o panorama dos casos de dengue no município, fortalecendo a transparência e subsidiando a tomada de decisões por parte das equipes e gestores;
- Ampliar e qualificar o acesso na Atenção Primária à Saúde (APS), promovendo a cobertura territorial com equipes completas, especialmente em áreas com maior vulnerabilidade social e risco aumentado de transmissão;
- Fortalecer os serviços com horário estendido nas Unidades Básicas de Saúde do Gastão, Meia Praia I e Alto São Bento, que desempenham papel fundamental na ampliação do acesso da população, especialmente em horários alternativos, reduzindo a pressão sobre os serviços de urgência e emergência;
- Valorizar o papel da Unidade de Saúde da Rua 424, que atua como ponto de referência para atendimento de casos agudos de baixa complexidade, prestando suporte às demais UBSs e qualificando o fluxo de atendimento no município;
- Orientar e participar ativamente da organização da rede de assistência, garantindo fluxos de atendimento adequados para pacientes com sinais de agravamento clínico e mantendo a retaguarda necessária para os casos moderados e graves;

- integrar as ações da APS com a atuação dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), ampliando o monitoramento dos territórios, o combate aos focos do mosquito Aedes aegypti e o acompanhamento de casos suspeitos;
- Fomentar ações intersetoriais, envolvendo as secretarias municipais, lideranças comunitárias e demais atores estratégicos, conforme a situação epidemiológica local, promovendo a corresponsabilização no enfrentamento às arboviroses.

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

- Elaborar, atualizar e monitorar periodicamente a curva epidêmica das arboviroses, com base em dados históricos e em tempo real, subsidiando a tomada de decisão e a definição de níveis de resposta;
- Analisar criticamente os dados obtidos por meio do monitoramento epidemiológico e entomológico, bem como informações provenientes de rumores, redes sociais e notificações espontâneas, a fim de identificar precocemente possíveis alterações no padrão de ocorrência;
- Elaborar e divulgar periodicamente Informes Epidemiológicos, contendo o panorama atualizado dos casos de dengue, chikungunya e Zika, bem como a situação entomológica do município, permitindo o acompanhamento da evolução dos indicadores por gestores e profissionais de saúde;
- Emitir alertas epidemiológicos formais, com base em critérios técnicos, para mobilização de ações de controle e intensificação de medidas de prevenção e assistência à saúde da população;
- Acompanhar a detecção e o monitoramento viral, em articulação com o laboratório de referência, considerando os dados laboratoriais disponíveis e priorizando a identificação de sorotipos circulantes;
- Avaliar e adequar continuamente o sistema de vigilância laboratorial, levando em conta os resultados das ações realizadas em ciclos anteriores, com foco no aprimoramento da capacidade de resposta diagnóstica e logística de insumos e materiais;

- Assessorar tecnicamente as equipes locais na definição de indicadores estratégicos a serem monitorados, de forma a garantir a padronização, sensibilidade e agilidade do sistema de vigilância em saúde.

MANEJO INTEGRADO DE VETORES

- Elaboração e execução de estratégias específicas para o controle do vetor, considerando as características locais, o cenário epidemiológico e os indicadores entomológicos;
- Realização imediata de ações de bloqueio de transmissão a partir da notificação dos primeiros casos suspeitos ou confirmados, com foco na visita casa a casa, eliminação de criadouros, aplicação de larvicidas e tratamento focal, de forma a interromper precocemente a cadeia de transmissão;
- Fomento à educação em saúde junto à população, visando ampliar a conscientização sobre a importância da eliminação de possíveis focos do mosquito Aedes aegypti no ambiente domiciliar e peridomiciliar, estimulando a corresponsabilidade da comunidade nas ações de prevenção;
- Estímulo à capacitação, qualificação e atualização contínua dos profissionais das equipes de vigilância ambiental, garantindo que estejam tecnicamente preparados para a execução das atividades de controle vetorial, manejo de inseticidas, investigação de casos e levantamento de índices entomológicos;
- Promoção de ações intersetoriais e parcerias com escolas, lideranças comunitárias e demais setores municipais, com foco na mobilização social e sustentabilidade das ações de prevenção ao longo de todo o ano.

COMUNICAÇÃO

- Desenvolver campanhas de sensibilização e mobilização social voltadas à prevenção da dengue, chikungunya e Zika, com uso de materiais informativos acessíveis (folders, cartazes, vídeos, cards digitais) e veiculação em rádios locais, redes sociais da prefeitura e demais canais de mídia disponíveis;
- Divulgar, de forma clara e contínua, informações sobre sinais e sintomas das arboviroses, orientações para busca de atendimento precoce e prevenção domiciliar, por meio de boletins informativos, mídias digitais da Secretaria de

Saúde de Itapema e espaços de mídia local;

- Disponibilizar semanalmente boletins epidemiológicos com dados atualizados sobre os casos de dengue no município, fortalecendo a transparência das ações e subsidiando gestores, profissionais de saúde e a população com informações confiáveis;
- Fomentar campanhas educativas nos bairros com maior incidência de casos e/ou notificações de surtos, utilizando linguagem simples, direta e adaptada à realidade local;
- Manter articulação com os setores de comunicação da Prefeitura e das Unidades de Saúde, apoiando tecnicamente na produção e disseminação de conteúdo informativo de qualidade, com linguagem adequada aos diferentes públicos;
- Apoiar as equipes das Unidades de Saúde e Vigilância em Saúde na organização de atividades comunitárias e educativas, como mutirões, palestras em escolas, visitas domiciliares e ações em feiras e espaços públicos;
- Promover a comunicação interna entre as equipes de saúde (APS, vigilância, atenção especializada), garantindo alinhamento nas mensagens e estratégias utilizadas, com base em dados atualizados e linguagem unificada.

ASSISTÊNCIA AO PACIENTE

- Assegurar a utilização dos protocolos clínicos do Ministério da Saúde, bem como do Protocolo de Enfermagem do COREN, por todos os profissionais de saúde, especialmente aqueles atuantes na Atenção Primária e nos serviços de urgência e emergência.
- Estimular, em todas as unidades de saúde que realizam atendimento a casos suspeitos ou confirmados de dengue, a importância da hidratação precoce dos pacientes, desde o primeiro contato clínico, conforme fluxograma de manejo preconizado pelo Ministério da Saúde.
- Manter estoques adequados de insumos e medicamentos utilizados no tratamento de pacientes com dengue, considerando a possibilidade de aumento do número de casos durante períodos epidêmicos.

- Estimular o uso do Cartão de Acompanhamento de Pacientes com Dengue, como instrumento de monitoramento e seguimento clínico dos casos, especialmente nos casos de dengue com sinais de alarme.
- Orientar e incentivar a utilização da Educação Permanente como estratégia para qualificação contínua dos profissionais da Atenção Primária em Saúde, com foco no reconhecimento precoce dos sinais de gravidade, manejo clínico adequado e promoção do cuidado humanizado.
- Promover o uso do Aplicativo de Manejo Clínico da Dengue, desenvolvido pela Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina, disponível em: https://protocolodengue.saude.sc.gov.br/app_dengue/, como ferramenta de apoio à tomada de decisão clínica.
- Intensificar a orientação e capacitação dos profissionais de saúde quanto ao manejo clínico da dengue, com ênfase na estratificação de risco, indicação de exames complementares e critérios para internação.
  Reforçar a aplicação do Fluxograma de Classificação de Risco e Manejo Clínico da Dengue, conforme as diretrizes vigentes do Ministério da Saúde, como instrumento padronizado de atendimento e organização do cuidado.

5.NÍVEIS DE ALERTA DO PLANO DE CONTINGÊNCIA

O Plano de Contingência é um documento orientador que apoia gestores e profissionais de saúde na tomada de decisões. Ele incorpora aprendizados da prática cotidiana e é aplicado por meio de ações definidas para três níveis de alerta, estabelecidos com base em indicadores específicos de acionamento, dividido em 03 níveis de alerta.

Nivel 1		
Dengue: - Taxa de incidência de casos prováveis de dengue,por duas semanas epidemiológicas consecutivas, em comparação ao ano anterior. - Aumento da incidência dos casos prováveis de dengue dentro do canal endêmico do diagrama de controle;	**Chikungunya** - Aumento na taxa de incidência de casos prováveis, em comparação ao mesmo período do ano anterior por duas semanas consecutivas. E/OU - Aumento da taxa de positividade laboratorial (RT-PCR) acima da taxa de incidência do ano anterior.	**Zika** - Aumento na taxa de incidência de casos prováveis, em comparação ao mesmo período do ano anterior por duas semanas consecutivas. E/OU - Aumento da taxa de positividade laboratorial (RT-PCR) acima da taxa de incidência do ano anterior.

Nivel 2		
Dengue: - Taxa de incidência de casos prováveis de dengue,por duas semanas epidemiológicas consecutivas, em comparação ao ano anterior, associado a sinais de gravidade. - Aumento da incidência dos casos prováveis de dengue dentro do canal endêmico do diagrama de controle com circulação de mais de soro tipo no município; - Aumento na ocorrência de óbitos suspeitos ou confirmados.	**Chikungunya** - Aumento na taxa de incidência de casos prováveis, em comparação ao mesmo período do ano anterior por duas semanas consecutivas. E/OU - Aumento na ocorrência de óbitos suspeitos ou confirmados.	**Zika** - Aumento da taxa de positividade laboratorial (RT-PCR) acima da taxa de incidência do ano anterior.

Nivel 3		
Dengue: - Taxa de incidência de casos prováveis de dengue,por duas semanas epidemiológicas consecutivas, permanece em ascensão. - Aumento na ocorrência de óbitos suspeitos ou confirmados.	**Chikungunya** - Aumento exponencial da incidência dos casos prováveis de chikungunya, por duas semanas consecutivas. E/OU - Aumento na ocorrência de óbitos suspeitos ou confirmados.	**Zika** - Aumento da taxa de positividade laboratorial (RT-PCR) acima da taxa na população em comparação ao ano anterior por duas semanas.

Além dos indicadores de acionamento definidos para cada nível de alerta, devem ser monitoradas outras situações que indiquem aumento da transmissão de dengue, chikungunya e zika. As ações devem estar alinhadas à Estratégia Estadual de Prevenção e Controle das Arboviroses e às orientações técnicas disponíveis na página da DIVE/SC.

Durante as visitas domiciliares, os agentes de endemias e comunitários devem estar atentos a casos suspeitos não notificados, considerando que muitos pacientes recorrem à automedicação, o que pode mascarar a real situação epidemiológica da área.

A definição dos níveis de alerta pode ser reavaliada conforme o cenário epidemiológico vigente e as situações de risco identificadas, com base em indicadores atualizados que subsidiem a tomada de decisão e a implementação de ações adequadas.

5.1 AÇÕES A SEREM EXECUTADAS NO NÍVEL 1

Ao avaliar os níveis de medidas a serem adotadas, é imprescindível considerar os dados de índices de infestação, o número de casos notificados e/ou confirmados, bem como os registros de casos com sinais de alarme, casos graves e óbitos.

Cada nível de planejamento deve ser analisado de forma integrada por todas as áreas envolvidas no enfrentamento desses agravos. Quando necessário, outros setores e níveis de gestão poderão ser acionados para contribuir com as ações.

Dessa forma, cada área de atuação seguirá com as medidas correspondentes ao nível em que o município se encontra. Abaixo, estão relacionadas todas as ações previstas, já organizadas por área ou setor responsável:

Nivel 1		
Dengue: - Taxa de incidência de casos prováveis de dengue,por duas semanas epidemiológicas consecutivas, em comparação ao ano anterior. - Aumento da incidência dos casos prováveis de dengue dentro do canal endêmico do diagrama de controle;	**Chikungunya** - Aumento na taxa de incidência de casos prováveis, em comparação ao mesmo período do ano anterior por duas semanas consecutivas. E/OU - Aumento da taxa de positividade laboratorial (RT-PCR) acima da taxa de incidência do ano anterior.	**Zika** - Aumento na taxa de incidência de casos prováveis, em comparação ao mesmo período do ano anterior por duas semanas consecutivas. E/OU - Aumento da taxa de positividade laboratorial (RT-PCR) acima da taxa de incidência do ano anterior.

5.1.1 Gestão

- Prover os insumos necessários, estabelecendo contratos que garantam estoques de insumos essenciais e equipamentos médicos, além de programar, com antecedência, a aquisição de medicamentos.
- Assegurar recursos humanos adequados para fornecer suporte técnico às ações de saúde, tanto nas Unidades Básicas de Saúde quanto nas Unidades de Pronto Atendimento.
- Apoiar a Vigilância Epidemiológica na emissão de alertas e na divulgação de orientações sobre prevenção e manejo clínico.
- Expandir os locais de testagem, com prioridade para a Atenção Primária à Saúde, a fim de evitar a sobrecarga nos serviços de urgência e emergência.
- Aprimorar a cobertura da Atenção Primária à Saúde em áreas prioritárias, com a implantação de equipes temporárias, se necessário para evitar sobrecarga dos serviços de emergência.
- Integrar as ações de controle do *Aedes aegypti* à Atenção Primária à Saúde, com a participação ativa dos Agentes Comunitários de Saúde.
- Inserir a discussão sobre doenças como dengue, chikungunya e zika nas agendas dos órgãos de saúde, fortalecendo o compromisso com o enfrentamento desses agravos.
- Facilitar o uso adequado dos recursos financeiros disponíveis para as atividades de controle vetorial e de assistência à saúde.
- Promover ações intersetoriais adaptadas à situação entomo-epidemiológica, utilizando os alertas da Defesa Civil para informar a população sobre áreas de risco.
- Ativar os Centros de Operações de Emergência para monitoramento das ações no município, além de promover a formação de comitês intersetoriais para o controle do *Aedes aegypti*.
- Realizar oficinas e reuniões com gestores para organizar os serviços de saúde e implementar os Planos de Contingência e de Ação.
- Se necessário, considerar a solicitação de horas extras para profissionais de diversas áreas, vigilância ambiental, vigilância epidemiológica e assistência à saúde, conforme a demanda apresentada.

- Cabe ainda à gestão, em colaboração com a equipe técnica, o desenvolvimento e a execução de ações adequadas ao nível de atenção requerido.

5.1.2 Vigilância Epidemiológica

- Utilizar o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e o Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL) para monitorar o aumento de casos prováveis e graves de dengue;
- Avaliar as áreas do município com transmissão contínua do vírus por pelo menos duas semanas consecutivas, utilizando critérios laboratoriais para confirmar o diagnóstico;
- Identificar áreas de risco e emitir alertas direcionados ao município.
- Monitorar os indicadores epidemiológicos e elaborar relatórios sobre a situação local, destacando as áreas com transmissão ativa, de modo a subsidiar a emissão de alertas e circulares.
- Reforçar as atividades de Educação Permanente, capacitando os profissionais de saúde e promovendo a conscientização sobre medidas preventivas.
- Analisar dados relevantes — como faixa etária, local provável de infecção, semana epidemiológica de início dos sintomas, critérios de confirmação, entre outros — e repassá-los às equipes de controle vetorial e atenção ao paciente.
- Manter a coleta de amostras para isolamento viral em áreas geograficamente representativas (por meio de unidades itinerantes), conforme as orientações da Secretaria Estadual de Saúde.
- Notificar, em até 24 horas, a ocorrência de óbitos suspeitos e/ou confirmados por dengue, realizando a investigação conforme o protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde.
- Elaborar mapas de calor a partir dos dados do SINAN, com os casos suspeitos e confirmados, para facilitar a visualização da distribuição espacial da doença.
- Conduzir a investigação de casos suspeitos, considerando o período de incubação da doença e os deslocamentos do indivíduo durante o período de viremia, a fim de determinar o Local Provável de Infecção (LPI) e possíveis locais de transmissão. Caso o paciente não seja localizado, acionar a Unidade Básica de Saúde (UBS) para realização de busca ativa.

- Comunicar, com a maior brevidade possível, os casos suspeitos e confirmados às equipes de controle vetorial, a fim de garantir a realização das ações de controle em tempo oportuno.

5.1.3 Controle Vetorial

- Realizar inspeções regulares para identificar a presença e prevalência de vetores, tais como os mosquitos transmissores da dengue, zika, chikungunya, entre outros.
- Em áreas infestadas, deve-se manter uma proporção de 1 (uma) armadilha para cada área de 300m x 300m, com inspeções semanais, com o objetivo de monitorar a presença do vetor e avaliar a efetividade das ações de controle.
- Realizar vistorias a cada 14 dias nos pontos estratégicos previamente definidos.
- Executar a coleta sistemática de dados referentes à distribuição e densidade dos vetores identificados, promovendo a análise contínua para detecção de tendências e identificação de áreas de maior risco.
- Implementar ações voltadas à redução da população de vetores, como o uso de inseticidas, larvicidas e práticas de manejo ambiental adequadas.
- Sempre que for detectada a presença de *Aedes aegypti*, realizar a delimitação de foco com a devida eliminação ou adequação de criadouros e tratamento focal com larvicidas.
- Realizar visitas domiciliares bimestrais a todos os imóveis localizados até o terceiro pavimento, em áreas classificadas como infestadas.
- Em áreas infestadas, proceder com o bloqueio de transmissão em um raio de 50 metros ao redor dos casos suspeitos e confirmados.
- Realizar a aplicação espacial de inseticida UBV nos locais onde houver casos confirmados de dengue, dentro do período oportuno, até o 14º dia após o início dos sintomas, com o objetivo de eliminar fêmeas do *Aedes aegypti* e conter a transmissão viral.
- Avaliar de forma contínua a necessidade de aquisição de insumos e equipamentos destinados às ações de controle vetorial, conforme o aumento do número de casos notificados.
- Desenvolver e implementar campanhas educativas voltadas à população sobre medidas de prevenção à proliferação de vetores e redução dos riscos de

transmissão de arboviroses. As ações devem contemplar finais de semana, escolas e centros comunitários.

- Solicitar, sempre que necessário, apoio da Secretaria de Obras para a eliminação de criadouros de mosquitos, bem como o suporte de outras secretarias em ações fiscalizatórias decorrentes de denúncias.
- Manter uma equipe devidamente capacitada e equipada para a realização de vistorias em locais de difícil acesso.
- Garantir que as informações obtidas em campo pelos agentes de endemias sejam devidamente repassadas à gestão para tomada de decisões estratégicas.
- Monitorar continuamente as condições ambientais que favorecem a proliferação de vetores, tais como clima, qualidade da água e gestão de resíduos sólidos.
- Priorizar o bloqueio de transmissão nos casos confirmados de chikungunya, adotando medidas de controle mais imediatas.
- Realizar aplicação de inseticida peridomiciliar nos primeiros casos confirmados de arboviroses, especialmente nos locais de provável infecção (residência, trabalho ou estudo) e nos imóveis adjacentes, em cenários de circulação viral.
- Executar o tratamento perifocal preventivo com aplicação de inseticida residual em pontos estratégicos, mediante avaliação técnica conjunta entre o município, GERSA e DIVE, independentemente da reincidência de focos do mosquito. Essa medida deve ser implementada de forma preventiva antes do período de maior transmissão, com periodicidade bimestral.

5.1.4 Assistência ao Paciente

Ressaltando que assistência ao paciente é subdividida entre a atenção primária à saúde e a média complexidade.

- Acompanhar e promover a implementação do Fluxograma de Classificação de Risco e Manejo Clínico para pacientes com suspeita de dengue, tanto na rede pública quanto na privada.
- Garantir a disponibilidade de ambientes adequados para oferecer suporte à hidratação oral imediata dos pacientes, logo na chegada às Unidades Básicas de Saúde (UBS), Unidade Básica de Atendimento Estendido – Morretes, e

Unidade de Pronto Atendimento (UPA), após a suspeita de dengue e a realização da classificação de risco.

- Organizar e facilitar treinamentos voltados ao manejo clínico de casos suspeitos de dengue, com a participação de equipes multidisciplinares.
- Incentivar e capacitar os profissionais da rede para a utilização do Protocolo Clínico de Manejo da Dengue do Ministério da Saúde, bem como o protocolo de enfermagem do COREN/SC específico para dengue.
- Orientar quanto ao uso e à incorporação de novas tecnologias no manejo clínico dos pacientes com dengue, como testes rápidos NS1 e hemoglobinômetro.
- Promover a utilização do Cartão de Acompanhamento do Paciente com Dengue, como ferramenta de monitoramento e continuidade do cuidado.
- Orientar todos os serviços de saúde sobre a importância da hidratação precoce dos pacientes desde a suspeita da doença, seguindo o fluxograma clínico e mantendo os estoques necessários de insumos e medicamentos.
- Orientar sobre a realização de hemogramas e/ou testes com hemoglobinômetro em casos suspeitos classificados a partir do Grupo B, garantindo a liberação rápida dos resultados para apoio ao diagnóstico e conduta.
- Monitorar os casos graves de dengue para subsidiar a definição de estratégias de organização dos serviços de saúde, inclusive com redirecionamento de recursos se necessário.
- Fortalecer os serviços de saúde para o manejo adequado de casos suspeitos e confirmados, seguindo as diretrizes técnicas estabelecidas.
- Incentivar e orientar os profissionais de saúde para a identificação precoce de casos suspeitos, notificação oportuna, realização do diagnóstico diferencial e aplicação correta do manejo clínico.
- Orientar os gestores municipais quanto à avaliação da capacidade instalada da Atenção Primária em áreas com alta transmissão, com vistas à otimização do atendimento conforme a demanda.
- Garantir o acolhimento, o reconhecimento precoce e o controle adequado de casos suspeitos, visando à interrupção da cadeia de transmissão e à redução da morbimortalidade.
- Realizar a notificação compulsória dos casos suspeitos e confirmados de dengue no prazo de até 24 horas, conforme normativas vigentes.

- Orientar os profissionais dos serviços de saúde e a população em geral sobre as medidas individuais e coletivas de prevenção e controle da dengue.
- Elaborar um fluxo de transporte pré-hospitalar para organizar os itinerários de encaminhamento de pacientes com casos moderados e graves.

5.1.5 Comunicação, Mobilização e Publicidade

- Disseminar informações entomológicas e epidemiológicas para os setores da Secretaria e para a população por meio do site da Prefeitura, mídias sociais, rádios e jornais de circulação regional.
- Promover campanhas de controle do *Aedes aegypti* em áreas com notificação de casos.
- Implementar estratégias de sensibilização para o combate à dengue, chikungunya e zika, utilizando material informativo e espaço na mídia.
- Realizar campanhas para eliminação ou adequação dos principais criadouros do *Aedes aegypti* identificados nos últimos boletins do Levantamento do Índice Rápido do *Aedes aegypti* (LIRAa/LIA). Manter o município informado de maneira sistemática sobre as ações a serem desenvolvidas e as estratégias a serem adotadas.
- Disponibilizar informações sobre sinais e sintomas das doenças no site da Prefeitura e nas mídias sociais.
- Divulgar os principais bairros e ruas com maior número de casos positivos para arboviroses.
- Divulgar a aplicação de UBV e os principais focos de arboviroses por meio de alertas (mensagens) da Defesa Civil.

5.2 AÇÕES A SEREM EXECUTADAS NO NÍVEL 2

Nivel 2		
Dengue: - Taxa de incidência de casos prováveis de dengue,por duas semanas epidemiológicas consecutivas, em comparação ao ano anterior, associado a sinais de gravidade. - Aumento da incidência dos casos prováveis de dengue dentro do canal endêmico do diagrama de controle com circulação de mais de soro tipo no município; - Aumento na ocorrência de óbitos suspeitos ou confirmados.	**Chikungunya** - Aumento na taxa de incidência de casos prováveis, em comparação ao mesmo período do ano anterior por duas semanas consecutivas. E/OU - Aumento na ocorrência de óbitos suspeitos ou confirmados.	**Zika** - Aumento da taxa de positividade laboratorial (RT-PCR) acima da taxa de incidência do ano anterior.

5.2.1 Gestão

- Intensificar todas as ações descritas no nível 1;
- Reavaliar a necessidade de contratação de recursos humanos para reforçar as equipes de saúde.
- Realizar levantamento de insumos e avaliar as necessidades de abastecimento para garantir o suprimento adequado.
- Realizar reuniões mensais e/ou conforme necessidade com a sala de situação municipal.
- Avaliar, juntamente com os setores envolvidos, a necessidade de decretar situação de emergência no município.
- Analisar as regiões com maior incidência de casos e considerar a possibilidade de extensão do horário de funcionamento das unidades de saúde para atender à demanda.
- Reforçar as equipes das unidades de pronto atendimento.
- Avaliar a necessidade de abertura de um centro de referência na área de maior incidência.
- Avaliar a necessidade de implantação de pontos de coleta para exames sorológicos.
- Expandir a equipe responsável pelo registro de dados no sistema SINAN, a fim de evitar a acumulação de informações.

5.2.2 Vigilância Epidemiológica

- Intensificar todas as ações descritas no nível 1.
- Reforçar o acompanhamento da incidência de casos por meio do monitoramento do SINAN e do GAL.
- Realizar a investigação de casos graves e óbitos relacionados às arboviroses.
- Efetuar análise diária dos dados epidemiológicos, laboratoriais e entomológicos.
- Divulgar orientações técnicas e reforçar a emissão de alertas.
- Avaliar o perfil dos casos com sinais de alarme ou gravidade.
- Avaliar, juntamente com a DIVE, a possibilidade de suspensão das LPI.
- Priorizar a realização das análises laboratoriais dos casos de chikungunya, zika e dengue com sinais de alarme, casos graves, gestantes e óbitos suspeitos de dengue.

5.2.3 Controle Vetorial

- Intensificar as ações descritas no nível 1.
- Avaliar, juntamente com a DIVE, a possibilidade de realização de UBV pesado nas áreas com maior número de casos.
- Solicitar reforço da equipe e insumos para intensificar as ações de controle vetorial.
- Realizar mutirões para a eliminação de criadouros e o recolhimento de lixo pesado.
- Avaliar, em conjunto com a DIVE, a possibilidade de desativar as armadilhas larvitrampas.
- Priorizar o bloqueio da transmissão em áreas com novos casos positivo**s.**

5.2.4 Assistência ao Paciente

- Intensificar as ações descritas no nível 1.
- Estruturar os serviços de saúde para garantir o atendimento adequado de casos graves, estabelecendo um fluxo claro e bem definido para o encaminhamento dos pacientes em todas as unidades de saúde.
- Estimular a participação ativa dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) no acompanhamento e suporte aos pacientes.
- Reforçar a capacitação e orientação dos profissionais de saúde quanto ao manejo clínico adequado das doenças.

5.2.5 Comunicação, Mobilização e Publicidade

- Intensificar todas as ações descritas no nível 1.
- Designar porta-vozes oficiais para transmitir informações aos meios de comunicação.
- Estabelecer novas estratégias de comunicação e publicidade direcionadas à população e à imprensa, informando sobre o aumento dos casos e as medidas a serem adotadas ao identificar sinais e sintomas.
- Utilizar carro e/ou moto de som para divulgação de alertas nas regiões com maior incidência.

5.3 AÇÕES A SEREM EXECUTADAS NO NÍVEL 3

Nivel 3		
Dengue: - Taxa de incidência de casos prováveis de dengue,por duas semanas epidemiológicas consecutivas, permanece em ascensão. - Aumento na ocorrência de óbitos suspeitos ou confirmados.	**Chikungunya** - Aumento exponencial da incidência dos casos prováveis de chikungunya, por duas semanas consecutivas. E/OU - Aumento na ocorrência de óbitos suspeitos ou confirmados.	**Zika** - Aumento da taxa de positividade laboratorial (RT-PCR) acima da taxa na população em comparação ao ano anterior por duas semanas.

5.3.1 Gestão

- Intensificar todas as ações previstas no Nível 2.
- Estabelecer diálogo com a Secretaria Estadual de Saúde de Santa Catarina (SES-SC) para garantir recursos destinados à ampliação de leitos clínicos para o atendimento dos casos suspeitos.

5.3.2 Vigilância Epidemiológica

- Intensificar as ações descritas no Nível 2;
- Analisar o perfil epidemiológico dos casos graves e óbitos por meio de investigação epidemiológica, possibilitando a elaboração de recomendações para a população e os serviços de saúde;
- Realizar a investigação de óbitos suspeitos ou confirmados relacionados à arboviroses, com o objetivo de identificar os fatores associados à sua ocorrência;

5.3.3 Controle Vetorial

- Intensificar as ações descritas no nível 2.
- Apurar infrações sanitárias por meio de Processo Administrativo específico, com foco em pontos estratégicos (PE), imóveis irregulares e locais sujeitos à inspeção sanitária, especialmente no contexto do licenciamento sanitário ou em casos de reincidência das irregularidades identificadas pela equipe de controle vetorial do município.

5.3.4 Assistência ao Paciente

- Intensificar todas as ações previstas no Nível 2.
- Reforçar a aplicação do Fluxograma de Classificação de Risco e Manejo Clínico nas unidades de saúde.
- Avaliar a necessidade de solicitar apoio técnico presencial da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina (SES-SC) e/ou do Ministério da Saúde.

5.3.5 Comunicação, Mobilização e Publicidade

- Intensificar todas as ações previstas no Nível 2;
- Organizar as entrevistas e coletivas de imprensa.

6. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

Cada área de atuação será responsável pela execução das ações correspondentes e, quando necessário, poderão ser acionados outros níveis e setores que possam contribuir com as medidas adotadas.

A partir da análise da incidência de casos no município, será possível planejar e programar as ações de forma mais estratégica, otimizando o tratamento e contribuindo para a redução efetiva dos casos.

O retorno gradual entre os níveis de ativação do Plano de Contingência será definido com base no monitoramento entomo-epidemiológico, tendo como objetivo alcançar uma situação em que os casos se mantenham dentro do intervalo endêmico esperado. A desativação do plano estará diretamente relacionada ao nível de alerta vigente.

Na eventual ativação do Nível 3, será realizado um retorno progressivo até o Nível 1, mantendo-se as atividades da área técnica em continuidade.

Ressalta-se que a redução gradual das ações iniciadas não caracteriza negligência quanto à vigilância e ao monitoramento dos determinantes de saúde relacionados às arboviroses. As ações de vigilância em saúde seguirão sendo conduzidas pelos órgãos competentes, de forma contínua e responsável.

7. RESPONSÁVEIS

ÁREA/ SETOR	NOME	TELEFONE	E-MAIL
Secretário de Saúde	Fabrico Lazzarí	(47) 3267.1500	fafa@itapema.sc.gov.br
Vigilância Epidemiológica	Bruna Leticia Bressanine	(47)3267.1525/ 1530	vigilanciaepidemiologica@itapema.sc.gov.br
Programa Controle da Dengue	Lucimar Cristiane de Souza Pereira da Fonseca	(47) 3267 .1520	dengue@itapema.sc.gov.br
Laboratórios de Entomologia	Roseli Comarela Coronetti	(47) 3267.1520	laboratoriodengue@itapema.sc.gov.br
Vigilância Sanitária	João Romero	(47) 3267.1529	vigilanciasanitaria@itapema.sc.gov.br
Atenção Primária à Saúde	Fabiana Oliveira	(47) 3267.1500	Atencaobasica.direcao@itapema.sc.gov.br
Serviços Regulação e Controle	Deysi Chaves de Souza	(47) 3267.1507	complexoreguladoritp@gmail.com
Hospital Santo Antônio	Isabela Vanolli Esser	(47)3268. 5986	assistencial.hsai@portalredeh.org
Unidade de Pronto Atendimento	Bruna Santos Piacesi	(47)98448.2989 (47)3224.9118	coordenacaoenfermagem.upaitapema@imas.net.br
Unidade de saúde Estendido - Morretes	Lidiane da Cruz Arruda	(47)3267.1555	pa.morretes@itapema.sc.gov.br
Assessoria de Comunicação, Mobilização e Publicidade	Émerson dos Santos de Oliveira	(47) 3268.8029	pauta@itapema.sc.gov.br

8. REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Departamento de Doenças Transmissíveis.**DENGUE DIAGNÓSTICO E MANEJO CLÍNICO: Crianças e adultos.** 6ª Ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2024, 62p.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. **Diretrizes Nacionais para a Prevenção e Controle de Epidemias de Dengue**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2009. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/svsa/dengue/diretrizes_nacionais_prevencao_controle_dengue.pdf/view

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Articulação Estratégica de Vigilância em Saúde. **Guia de Vigilância em Saúde**. 5. ed. rev- Brasília : Ministério da Saúde, 2022. Disponível em: https://dive.sc.gov.br/phocadownload/guia-vigilancia/2022/GV5-5edicao-04-05-2022.pdf

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Especializada à Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. **Diretrizes para a organização dos serviços de atenção à saúde em situação de aumento de casos ou de epidemia por arboviroses.** Brasília : Ministério da Saúde, 2022. Disponível em: https://dive.sc.gov.br/phocadownload/doencas-agravos/Dengue/Publicacoes/CASOS/Epidemia-ARBOVIROSES-25-04-2022.pdf

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis. **Plano de contingência nacional para dengue, chikungunya e Zika**. Brasília : Ministério da Saúde, 2025. Disponível: https://dive.sc.gov.br/phocadownload/doencas-agravos/Dengue/Publicacoes/plano-contingencia-nacional-dengue-chikungunya-zika-2025.pdf
Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente.

DIVE - Diretoria de Vigilância Epidemiológica. Superintendência de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina. **Diretrizes para a organização dos serviços de atenção à saúde em situação de aumento de casos ou epidemia de Dengue no estado de Santa Catarina**. Versão 2.0, Março de 2023. Disponível em: https://dive.sc.gov.br/phocadownload/doencas-agravos/Dengue/Publicacoes/CASOS/diretrizes-dengue-sc-versao-2.pdf

SANTA CATARINA. Diretoria de Vigilância Epidemiológica. *Diretrizes estaduais para prevenção e controle das arboviroses humanas – 2025*. Florianópolis: DIVE/SC, 2025. Disponível em: https://dive.sc.gov.br/phocadownload/doencas-agravos/Dengue/Publicacoes/diretrizes%20estaduais%20para%20preveno%20e%20controle%20das%20arboviroses%20humanas%20-%202025.pdf. Acesso em: 17 out. 2025.

SANTA CATARINA. Diretoria de Vigilância Epidemiológica. *Plano de contingência dengue – 2025*. Florianópolis: DIVE/SC, 2025. Disponível em: https://dive.sc.gov.br/phocadownload/doencas-agravos/Dengue/Publicacoes/plano%20de%20contingncia%20dengue%20-%202025%202.pdf. Acesso em: 17 out. 2025.

GOVERNO DE SANTA CATARINA. Secretaria de Estado da Saúde. Superintendência de Vigilância em Saúde.Diretoria de Vigilância Epidemiológica. Gerência de Zoonoses, Acidentes por Animais Peçonhentos e Doenças Transmitidas por Vetores. **Fluxograma de Classificação de risco e manejo do paciente com suspeita de dengue** - 2024.